

FUNIL DE LEAD DINÂMICO

Estratégia Completa

Big idea, funil de quiz, página de aplicação, anúncios, relatório de diagnóstico, cadência de follow-up e recomendações estratégicas.

CLIENTE

Guilherme Eduardo

ESTRATEGISTA

Daniel Souza

SIMPLE · 2026

Estrategista: Daniel Souza · **Expert:** Guilherme Eduardo (GES Consultoria Médica)

Negócio em uma linha: consultoria de implantação (Método GES360) que tira o médico dono de clínica da consulta avulsa e instala um modelo de receita recorrente (programas de acompanhamento), dobrando o faturamento sem aumentar o número de atendimentos.

Frente única: saúde (médico dono de clínica já estabelecida). Funil de aplicação via quiz (Funil de Lead Dinâmico), com o não-ICP direcionado ao produto de entrada de 45 dias (R\$ 7.500).

Premissas assumidas (confirmadas no canvas do cliente): esteira em 3 degraus (45 dias R\$ 7.500 · Implementação 3 meses R\$ 15.000 · Programa 12 meses R\$ 30.000). Corte de qualificação do quiz em R\$ 50 mil/mês de faturamento (coerente com o ICP de R\$ 50 mil a R\$ 100 mil+). Conversão de call de 50% e comparecimento de 80% (benchmarks Simple). O segredo do método é a ordem: preço e protocolo antes de tráfego.

1. Big Idea

O problema da sua clínica não é falta de paciente. É o modelo que você usa para faturar.

O médico estuda anos para dominar a técnica, mas ninguém ensina o negócio. Aí ele enche a agenda de consulta avulsa e, no fim do mês, o dinheiro não sobra e o tempo some. Crescer, nesse modelo, é atender mais, e atender mais tem teto: a sua própria saúde. A virada do **GES360** é contraintuitiva: antes de trazer mais paciente, a clínica precisa de um modelo de receita que converte e retém. Preço e protocolo primeiro, tráfego depois. Uma clínica que fatura no teto da consulta avulsa está a um programa de acompanhamento de dobrar o faturamento, sem atender mais. Não por falta de paciente, por falta de um modelo que funcione.

2. Copy do Quiz

HERO DA PÁGINA DO QUIZ

Título: Descubra o que está travando o faturamento da sua clínica

Subtítulo: Responda em 2 minutos e receba um diagnóstico personalizado no seu WhatsApp, com o próximo passo para dobrar o faturamento sem aumentar os atendimentos.

Tempo estimado: 2 minutos · **CTA:** Começar meu diagnóstico

PERGUNTAS (PADRÃO SPIN, QUALIFICAÇÃO POR ÚLTIMO)

P1 · Situação. Como é a sua clínica hoje?

- a) Clínica ou consultório próprio, atendo e cuido de tudo
- b) Divido clínica com outros profissionais
- c) Tenho clínica com secretária e equipe
- d) Estou estruturando o negócio agora

P2 · Situação. Como você cobra hoje?

- a) Só consulta avulsa
- b) Consulta avulsa e, às vezes, tento vender acompanhamento
- c) Já tenho programa de acompanhamento, mas vende pouco
- d) O acompanhamento já é a maior parte da minha receita

P3 · Problema. O que mais trava o seu faturamento neste momento?

- a) Dependo de consulta avulsa e não sobra no fim do mês
- b) Ofereço o programa e o paciente acha caro, não fecha
- c) Tenho dificuldade ou vergonha de vender
- d) Não tenho um programa estruturado para oferecer

P4 · Implicação. Se nada mudar, como fica a sua clínica daqui a 12 meses?

- a) Igual: trabalhando muito para o mesmo faturamento
- b) Pior: mais cansado e com menos tempo para a família
- c) Não sei, e isso me preocupa
- d) Vou crescer, mas à custa da minha saúde e da minha vida

P5 · Tentativas. O que você já tentou para faturar mais?

- a) Tráfego pago ou anúncios
- b) Cursos e mentorias de gestão ou marketing médico
- c) Postar mais no Instagram
- d) Ainda não tentei nada estruturado

P6 · Objetivo. O que você mais quer nos próximos 6 meses?

- a) Faturar mais sem aumentar o número de atendimentos
- b) Ter previsibilidade de receita todo mês
- c) Vender os meus programas com naturalidade
- d) Sair dos plantões e focar só na clínica

P7 · Perfil. Qual é a sua especialidade?

- a) Nutrologia, medicina integrativa ou emagrecimento
- b) Ginecologia ou urologia
- c) Medicina esportiva ou tricologia
- d) Outra especialidade ou dono de clínica

P8 · Qualificação (filtro). Qual o faturamento mensal da sua clínica hoje?

- a) Até R\$ 20 mil
- b) De R\$ 20 a 50 mil
- c) De R\$ 50 a 100 mil
- d) Acima de R\$ 100 mil

REGRA DE SEGMENTAÇÃO

c e d na P8 (com demanda de paciente) = **ICP**: agenda o diagnóstico estratégico com o Guilherme.
a e b = oferta do **produto de entrada de 45 dias (R\$ 7.500)** e conteúdo de aquecimento. As respostas da P3 definem o gargalo que personaliza o relatório (seção 5).

CAPTURA DE DADOS (ÚLTIMA TELA)

Título: Seu diagnóstico está pronto

Subtítulo: Preencha abaixo para receber o relatório personalizado no seu WhatsApp (leva 30 segundos).

Campos: Nome · WhatsApp (com DDD) · E-mail · **CTA:** Receber meu diagnóstico

Privacidade: seus dados estão seguros. Sem spam, só o seu relatório e o próximo passo.

3. Copy · Página de Aplicação (Diagnóstico Estratégico)

Headline: Sua clínica está a um modelo de receita de dobrar o faturamento, sem atender mais.

Subheadline: Diagnóstico estratégico gratuito com Guilherme Eduardo para médicos donos de clínica que querem sair da consulta avulsa e faturar com previsibilidade.

Prova social (logo após o headline): [DEPOIMENTO em vídeo do Dr. Kayo] + faixa com prints de WhatsApp de médicos atendidos.

BLOCO DE DOR (ESPELHO DO ICP)

- Você atende o dia inteiro e, no fim do mês, o dinheiro não sobra como deveria.
- Depende da consulta avulsa: se você para de atender, o faturamento para junto.
- Oferece o programa e o paciente acha caro, ou você trava na hora de vender.
- Vê médicos mais novos crescendo mais rápido e não entende por quê.
- Sabe que precisa mudar o modelo, mas não sabe por onde começar.

Virada: o problema não é falta de paciente nem falta de esforço. É o modelo. E modelo se troca.

REFRAME (O MECANISMO DO PROBLEMA)

A clínica cresce por três alavancas: o **modelo de receita** (o que você vende), a **conversão na consulta** (transformar atendimento em programa) e a **atração** (paciente certo chegando). O médico aprendeu a ser excelente na consulta, mas ninguém ensinou as três alavancas. Resultado: mais esforço no modelo errado, mais cansaço, o mesmo faturamento.

MECANISMO ÚNICO (O MÉTODO GES360)

- **1. Modelo de Receita:** sair da consulta avulsa para programas de acompanhamento, com preço e protocolo estruturados primeiro.
- **2. Comercial:** a Metodologia de Conversão em Consulta (6 etapas) e o treinamento da secretária, para o paciente fechar o programa sem você precisar "empurrar".
- **3. Atração de Pacientes:** reativação de base, indicação e posicionamento, e só então tráfego.

O segredo é a ordem: **preço e protocolo antes de tráfego**. De nada adianta trazer mais paciente para um sistema que ainda não converte nem retém. O resultado começa a aparecer já na primeira semana.

AUTORIDADE

Guilherme Eduardo, estrategista de clínicas médicas e fundador da GES Consultoria Médica. O Método GES360 tem cases reais de médicos que reorganizaram o modelo de receita e destravaram o faturamento (um deles saiu de R\$ 20 mil para R\$ 86 mil em um mês, sem atender mais). Implementação assistida e ao vivo, não curso gravado.

OFERTA DA PÁGINA

Diagnóstico estratégico gratuito de 30 a 45 minutos: leitura do seu momento e o desenho do próximo passo mais lucrativo para a sua clínica. Sem compromisso e sem enrolação.

CTA primário: Quero meu diagnóstico estratégico

Reforço: as agendas da semana são limitadas (máximo de sessões por dia definido pelo próprio Guilherme).

PARA QUEM É / PARA QUEM NÃO É

- ✓ Médico dono de clínica com demanda de paciente, que travou no faturamento.
- ✓ Quem quer sair da consulta avulsa para um modelo de receita recorrente.
- ✓ Quem está disposto a executar um método com disciplina.
- ✗ Quem está começando do zero, sem pacientes chegando.
- ✗ Quem procura fórmula mágica sem execução.
- ✗ Quem não pode investir no próprio crescimento agora.

FAQ

É curso ou consultoria? Nenhum dos dois: é implementação assistida, ao vivo, com método e acompanhamento. Você executa com direção e vê resultado já no início.

Não tenho tempo. É exatamente por isso. O método organiza o modelo de receita para você faturar mais sem atender mais.

E se eu não sou bom em vendas? A Metodologia de Conversão em Consulta (6 etapas) instala o processo comercial dentro da sua consulta e treina a sua secretária. Vender deixa de depender de talento.

Funciona para a minha especialidade? O método é de modelo de receita, não de especialidade: nutrologia, ginecologia, urologia, esportiva, integrativa, tricologia, emagrecimento.

Quanto custa? O diagnóstico é gratuito. Se fizer sentido para os dois lados, o Guilherme apresenta o formato e o investimento na própria sessão.

CTA final: Agendar meu diagnóstico estratégico gratuito

Microcopy: seus dados ficam só com a equipe do Guilherme. Sem spam.

4. Copy dos Anúncios

PRINCÍPIO DE MÍDIA (DANIEL)

Falar sempre com o **médico dono de clínica**, nunca com o paciente. Subir **3 conjuntos, cada um com 10 anúncios** (um conjunto por ângulo: dor, mecanismo e autoridade), variando gancho, copy e criativo. Linguagem de **diagnóstico**, nunca promessa de ganho (política da Meta e CFM).

Big Idea do anúncio: não é falta de paciente. É o modelo que você usa para faturar.

Ângulo 1 · Dor e identificação (conjunto 1, 10 anúncios)

Estratégia: espelhar a rotina do médico e nomear a dor que ele ainda não nomeou.

Hook (3s): "Agenda cheia não é faturamento."

Copy curta (~50): Agenda cheia não é faturamento. Se você atende o dia inteiro e o fim do mês continua apertado, o problema não é falta de paciente: é o modelo da sua clínica. Faça o diagnóstico gratuito de 2 minutos e descubra o que está travando o seu faturamento.

Copy média (~120): Tem médico que virou funcionário da própria clínica: agenda lotada, semana sem respiro e um faturamento que não conversa com o tanto que trabalha. Isso não se resolve atendendo mais. A clínica cresce por três alavancas: o modelo de receita, a conversão na consulta e a atração de paciente certo. Quando você depende só de consulta avulsa, o faturamento trava e a conta chega no seu tempo e na sua família. O diagnóstico gratuito do Guilherme Eduardo mostra, em 2 minutos, o que está travando a sua clínica e qual o próximo passo. Clica, responde e recebe o relatório no seu WhatsApp.

Copy longa (~250): Ninguém te ensinou isso na faculdade: ser excelente na consulta não faz a clínica faturar. Você estudou anos para dominar a técnica, montou o seu consultório, encheu a agenda, e descobriu que agenda cheia não é faturamento. O número travou num patamar, todo mês parecido, e a única saída que parece existir é atender ainda mais. Só que essa saída tem teto, e o teto é a sua saúde. A verdade que quase ninguém fala para o médico: o problema não é falta de paciente, é o modelo que você usa para faturar. A clínica cresce por três alavancas: um modelo de receita que sai da consulta avulsa e vai para o acompanhamento, a conversão dentro da consulta (o paciente fechando o programa) e a atração de paciente certo. Quando as três funcionam, uma clínica que fatura no teto da avulsa dobra sem atender mais. O Guilherme Eduardo instala exatamente essa virada com médicos donos de clínica: modelo de receita, processo comercial e posicionamento, na ordem certa. O primeiro passo é gratuito: um diagnóstico de 2 minutos que lê o momento da sua clínica e devolve um relatório personalizado no seu WhatsApp, com o gargalo identificado e o próximo movimento. Clica em Saiba mais e responde o seu diagnóstico.

Ângulo 2 · Mecanismo único (conjunto 2, 10 anúncios)

Estratégia: a virada contraintuitiva (preço e protocolo antes de tráfego; a consulta que converte).

Hook (3s): "Sua clínica atende muito bem. Só que atender não é vender."

Copy curta (~50): Sua clínica atende muito bem, mas atender não é vender. O paciente elogia, "vai pensar" e some, e o programa não fecha. A clínica que instala um processo comercial na consulta dobra sem precisar de mais paciente. Faça o diagnóstico gratuito e veja o que falta na sua.

Copy média (~120): Toda clínica presa na consulta avulsa está a um modelo de receita de dobrar o faturamento. Não é mais tráfego, não é mais diploma, não é atender até mais tarde. É modelo: sair da consulta avulsa para programas de acompanhamento, com preço e protocolo estruturados, e uma consulta que conduz o paciente até o fechamento (a Metodologia de Conversão em Consulta). O Guilherme Eduardo instala exatamente isso: Modelo de Receita, Comercial e Atração, na ordem certa, com resultado já na primeira semana. Comece pelo diagnóstico gratuito: 2 minutos e você recebe no WhatsApp a leitura do seu momento e o próximo passo.

Copy longa (~250): Existe um faturamento parado dentro da sua clínica, e ele não precisa de nenhum paciente novo para aparecer. Ele está no paciente que "vai pensar" e nunca mais recebe uma mensagem, no programa que você tem vergonha de oferecer, no preço defasado que ninguém reajusta, na consulta que só atende em vez de conduzir até o fechamento. O médico aprende tudo sobre a técnica e quase nada sobre o negócio, e aí a clínica atende muito bem e vende mal. A virada que o Guilherme Eduardo aplica tem uma ordem que quase ninguém respeita: preço e protocolo antes de tráfego. Primeiro o Modelo de Receita (a clínica sai da consulta avulsa e monta os programas de acompanhamento). Depois o Comercial (a Metodologia de Conversão em Consulta, em 6 etapas, e a secretária treinada para não perder lead). Só então a Atração (reativação de base, indicação e tráfego). Porque de nada adianta trazer mais paciente para um sistema que não converte nem retém. Antes de qualquer conversa, o primeiro passo é entender o seu momento: o diagnóstico gratuito lê a sua clínica em 2 minutos e devolve um relatório personalizado no seu WhatsApp com o gargalo e o próximo movimento. Clica e responde agora.

Ângulo 3 · Prova e autoridade (conjunto 3, 10 anúncios)

Estratégia: case real do nicho (médico fala com médico), sem prometer resultado (CFM e Meta).

Hook (3s): "Um médico saiu de R\$ 20 mil para R\$ 86 mil em um mês. Sem atender mais. Veja o que mudou."

Copy curta (~50): Um médico que atendia no teto da consulta avulsa reorganizou o modelo de receita e mudou de patamar em um mês, sem atender mais. O que mudou não foi a agenda, foi o modelo. Faça o diagnóstico gratuito e descubra o que dá para destravar na sua clínica.

Copy média (~120): O Guilherme Eduardo trabalha com uma tese simples: o médico não precisa de mais paciente, precisa de um modelo de receita. Um dos médicos que aplicou o método saiu de um faturamento travado para outro patamar em poucas semanas, apenas reorganizando a oferta, o preço e a conversão da consulta. Sem plantão a mais, sem agenda a mais. [DEPOIMENTO: case real da saúde em uma linha]. Se a sua clínica funciona mas o faturamento travou, o diagnóstico gratuito mostra onde. 2 minutos, relatório no WhatsApp.

Copy longa (~250): Tem uma cena que se repete em quase toda clínica que o Guilherme Eduardo atende: o médico é excelente no que faz, os pacientes elogiam, indicam, voltam, e mesmo assim o faturamento está travado no mesmo patamar há meses. Quando ele olha o negócio por dentro, encontra sempre as mesmas coisas: dependência da consulta avulsa, nenhum programa estruturado, um preço abaixo do valor e uma consulta que atende mas não conduz até o fechamento. A tese do Guilherme é que o médico não precisa de mais paciente, precisa de um modelo de receita. Foi assim que um dos médicos que aplicou o Método GES360 saiu de R\$ 20 mil para R\$ 86 mil de faturamento em um mês, sem atender mais: só reorganizando a oferta, o preço, o protocolo e a conversão. [DEPOIMENTO: case com resultado concreto]. O método trabalha três pilares na ordem certa: Modelo de Receita, Comercial e Atração, com implementação ao vivo e acompanhamento. O caminho começa com um diagnóstico gratuito de 2 minutos: você responde, recebe um relatório personalizado no WhatsApp e, se fizer sentido, agenda uma sessão com o próprio Guilherme. Sem turma lotada, sem fórmula genérica. O link está aqui embaixo.

10 HEADLINES PARA TESTE A/B

1. Agenda cheia não é faturamento.
2. Não é falta de paciente. É o seu modelo de faturar.
3. Sua clínica está a um modelo de receita de dobrar o faturamento.
4. Sua clínica atende muito bem e vende mal (dá para mudar isso).
5. Ninguém te ensinou o negócio, só a medicina.
6. Clínica que depende de consulta avulsa tem teto.
7. O faturamento parado dentro da sua clínica.
8. Atender mais não é plano de crescimento.
9. Por que médicos excelentes faturam menos do que deviam.
10. Descubra em 2 minutos o que trava o faturamento da sua clínica.

5 HOOKS PARA VÍDEO

1. "Agenda cheia não é faturamento. E eu te provo em 40 segundos."
2. "Sua clínica atende muito bem. Só que atender não é vender, e a diferença vale o seu mês."
3. "O médico não precisa de mais paciente. Precisa de um modelo de receita."

4. "Se a sua clínica fatura no teto da consulta avulsa, ela está a um passo de dobrar. E o passo não é o que você pensa."
5. "Existe um faturamento parado dentro da sua clínica agora. Deixa eu te mostrar onde."

5. Relatório de Diagnóstico (entregue após o quiz)

COMO USAR

As {{variáveis}} são preenchidas pelas respostas do quiz. [DEPOIMENTO] = inserir prova real (vídeo ou print). [AGENDAR] = botão que leva ao WhatsApp/agenda. Tom: direto, de médico para médico, sem condescendência e sem prometer resultado (CFM).

Abertura: {{nome}}, aqui está o seu diagnóstico. Ele foi montado a partir das suas respostas, então é sobre a sua clínica, não um texto genérico.

Leitura do cenário: hoje você fatura {{faixa_faturamento}} e a maior parte da sua receita ainda vem de {{modelo_cobranca}}. O que mais trava você agora é {{gargalo}}. Esse é um ponto muito comum em {{especialidade}}, e é 100% resolvível.

O mecanismo do problema: a clínica cresce por três alavancas (modelo de receita, conversão na consulta e atração). O seu gargalo ({{gargalo}}) está na alavanca {{alavanca}}. Enquanto ela não é resolvida, mais paciente só aumenta o trabalho, não o faturamento.

Comparação de cenários: na consulta avulsa, cada mês recomeça do zero e o seu faturamento é do tamanho da sua agenda. Com um programa de acompanhamento bem estruturado, o mesmo paciente vale várias vezes mais e a receita fica previsível.

O custo de continuar: se nada mudar, daqui a 12 meses você tende a estar {{implicacao}}: mais cansado, no mesmo patamar, vendo colegas crescerem. O tempo perdido não volta.

O mecanismo da solução (GES360): primeiro o modelo de receita e o protocolo (preço certo, programa montado), depois o comercial (a Metodologia de Conversão em Consulta e a secretária treinada) e só então a atração. Nessa ordem, o resultado começa já na primeira semana.

O seu próximo passo: pelo seu perfil, o primeiro movimento é {{proximo_passo}}. É exatamente isso que a gente desenha no diagnóstico estratégico.

Prova: [DEPOIMENTO do Dr. Kayo: de R\$ 20 mil para R\$ 86 mil em um mês, reorganizando o modelo, sem atender mais].

Convite: o próximo passo é uma conversa de 30 a 45 minutos, gratuita, para desenhar isso na sua clínica. [AGENDAR meu diagnóstico estratégico].

Variações do {{gargalo}} por resposta da P3: (a) dependência de avulsa; (b) objeção de preço no fechamento; (c) trava de vendas; (d) falta de programa estruturado. Cada uma muda a alavanca, a implicação e o próximo passo.

6. Cadência de Follow-up · 12 dias (voz do Guilherme)

Níveis: N1 não respondeu · N2 engajou e parou · N3 quer agendar e adia · N4 no-show · N5 fez a call e não fechou. SDR do projeto: Elisa. Tom de médico para médico, respeitoso e direto.

Dia 1 (manhã): Doutor(a) {{nome}}, aqui é a Elisa, do time do Guilherme Eduardo. O seu diagnóstico chegou aí no WhatsApp? Qualquer coisa eu reenvio.

Dia 1 (tarde): o Guilherme viu o seu diagnóstico e comentou que o seu caso tem uma saída mais rápida do que parece. Quer que eu te mostre os horários do diagnóstico estratégico?

Dia 2: {{nome}}, separei dois horários na agenda do Guilherme esta semana: {{h1}} e {{h2}}. Qual encaixa melhor?

Dia 3: 🙄

Dia 4 (valor): um ponto do seu diagnóstico que vale destacar: clínicas com {{gargalo}} costumam recuperar faturamento só ajustando a oferta e a conversão da consulta, sem paciente novo. É o tipo de ajuste que o Guilherme desenha com você na sessão. Bora marcar?

Dia 5 (ligação): tentativa de ligação + mensagem: te liguei para agilizar o seu agendamento, doutor(a). Me diz um horário bom que eu ligo de novo.

Dia 6 (case): olha o que aconteceu com um médico que estava no mesmo ponto que você: [DEPOIMENTO curto]. A diferença foi o modelo, não a agenda.

Dia 7: 🙄

Dia 8 (valor): pergunta honesta, {{nome}}: se a sua clínica seguir igual pelos próximos 12 meses, tá tudo bem para você? Se a resposta incomodar, o diagnóstico é gratuito e resolve a dúvida do próximo passo.

Dia 9 (áudio do Guilherme): áudio curto, informal: " {{nome}}, Guilherme aqui. Vi o seu diagnóstico, o seu caso é dos que eu gosto: potencial grande e ajuste claro. Me dá 40 minutos que eu te mostro o desenho. Combina um horário com a Elisa."

Dia 10: {{nome}}, a agenda do Guilherme para a semana que vem abre hoje. Te guardo um horário?

Dia 11 (ligação): segunda tentativa de ligação + mensagem curta.

Dia 12 (pré break-up): {{nome}}, vou encerrar o seu acompanhamento por aqui para dar lugar à fila de diagnósticos. Se quiser retomar, é só me chamar nesta conversa. O seu diagnóstico fica salvo e a porta fica aberta. Sucesso na sua clínica!

N4 no-show: "imprevisto acontece, doutor(a). Te reencaixo ainda esta semana: {{h1}} ou {{h2}}?"

N5 não fechou: cadência quinzenal de valor (case + conteúdo) por 60 dias, com convite de retomada a cada 15 dias.

7. Recomendações Estratégicas

Sobre a oferta. A esteira de 3 degraus está no ponto: o produto de 45 dias (R\$ 7.500) monetiza o não-ICP do quiz e paga a mídia; a Implementação de 3 meses (R\$ 15.000) é o carro-chefe do funil e a que já vende; o Programa de 12 meses (R\$ 30.000) é o upsell natural, oferecido no calor do primeiro resultado (frenesi de compra). Prioridade: nunca dar desconto no high ticket; a régua de negociação é forma de pagamento ou downsell para o degrau de baixo.

Sobre o funil. O gargalo do Guilherme é volume de aquisição e o comercial, não a entrega (a entrega dá resultado). Por isso o manual anda junto com o tráfego desde o dia 1: as objeções reais das calls alimentam o quiz e os criativos. O próprio método já ensina a ordem certa (preço e protocolo antes de tráfego), e o funil respeita isso: qualifica no quiz, entrega valor no relatório e só leva para a sessão quem se reconheceu. Risco a vigiar: subir orçamento antes de validar CPL, conclusão do quiz e comparecimento.

Sobre conversão. A trava declarada do Guilherme ("eu não sou bom em vendas") é resolvida por três coisas: a Metodologia de Conversão em Consulta (que tira a venda do improviso), a Elisa carregando o volume de prospecção (o Guilherme entra só na sessão) e a revisão das 3 primeiras calls com o mentor. Documentar o processo desde já para poder delegar sem depender do fundador.

Visão de longo prazo. Os ativos únicos do Guilherme são a rede do mercado médico (farmácia de manipulação, implante hormonal, eventos que ele já circula), que vira canal de indicação e parceria, e o braço de tráfego para clínicas (2 médicos já pediram), que é a expansão do Roadmap 2. Contra concorrentes fortes (Sandro Ferraz e Cassiano Sávio atacam por volume e mindset), o diferencial é claro: implementação individual e operacional (protocolo, precificação, script, secretária) com resultado em 90 dias. E o ativo que mais precisa crescer agora é a prova social do nicho: cada case de médico documentado (com o Guia de Captação de Depoimentos já entregue) vale mais que qualquer criativo novo.